

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Body Shape Questionnaire — Cuestionario sobre la Forma Corporal (BSQ)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

ADVERTENCIA DE VERIFICACIÓN INICIAL (2026-08-10): se detectó por inspección visual directa de la página (no solo extracción de texto) que el Protocolo.pdf de este acervo presenta la escala de respuesta en orden INVERSO al de la publicación original de adaptación española (Raich et al., 1996, Clínica y Salud): en este protocolo local, la columna 1 corresponde a "Siempre" y la columna 6 a "Nunca" (de mayor a menor frecuencia); en el artículo original de 1996, el orden publicado es 1=Nunca ... 6=Siempre (de menor a mayor frecuencia). Ver sección 7 para el detalle y la recomendación de uso.

Familia / sigla	BSQ
Nombre completo	Body Shape Questionnaire — Cuestionario sobre la Forma Corporal
Versión / edición	Versión española de 34 ítems traducida y adaptada por Raich, R.M., Mora, M., Soler, A., Ávila, C., Clos, I., y Zapater, L., publicada en Clínica y Salud (1996), Vol. 7, Nº 1: "Adaptación de un instrumento de evaluación de la insatisfacción corporal". El propio artículo de 1996 indica que una versión experimental anterior ya había aparecido en Raich (1994).
Idioma	Español (España).
Autores (original)	Cooper, P. J., Taylor, M. J., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (originales, 1987). Adaptación española: Raich, R. M., Mora, M., Soler, A., Ávila, C., Clos, I., y Zapater, L.
Año (original / adaptación)	1987 (original, British Journal of Psychiatry / Int. J. Eating Disorders); 1996 (adaptación y validación española, Clínica y Salud).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Insatisfacción corporal; imagen corporal; conducta alimentaria; miedo a engordar; evitación por apariencia.
Pregunta clínica que responde	¿Hay preocupación clínicamente relevante por la forma corporal que sugiera riesgo de trastorno de conducta alimentaria o de imagen corporal?
Población	Diseñado y validado originalmente en población femenina adulta y universitaria (el propio artículo de 1996 indica explícitamente: "Se refiere únicamente a población femenina"); muestras del estudio de adaptación: 153 y 248 estudiantes universitarias, y pacientes con trastornos

	alimentarios (anorexia, bulimia, bulimarexia) del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Contexto de aplicación	Investigación y clínica de trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal; cribado de insatisfacción corporal.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual o colectivo.
Número de ítems	34 ítems (verificado por conteo directo en el Protocolo.pdf de este acervo y cotejado contra el anexo íntegro publicado en Raich et al., 1996).
Periodo temporal de referencia	Últimas cuatro semanas.
Formato de respuesta	Escala de 6 puntos de frecuencia. VER ADVERTENCIA: el Protocolo.pdf local presenta el orden 1=Siempre, 2=Casi siempre, 3=Con frecuencia, 4=Algunas veces, 5=Raramente, 6=Nunca (confirmado por inspección visual de la página, no solo texto extraído). El artículo original de adaptación española (Raich et al., 1996) publica el orden inverso: 1=Nunca, 2=Raramente, 3=Alguna vez, 4=A menudo, 5=Muy a menudo, 6=Siempre.
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 10-15 minutos).
Regla de puntuación	Suma directa de los 34 ítems. IMPORTANTE: los baremos y el punto de corte publicados (rango 34-204, corte orientativo de 105 según Raich, 2000) se calcularon con la convención 1=Nunca...6=Siempre (mayor puntuación = mayor insatisfacción). Si se administra el Protocolo.pdf de este acervo tal como está impreso (orden inverso), es imprescindible invertir la puntuación de cada ítem ($\text{puntuación_corregida} = 7 - \text{valor_marcado}$) antes de sumar y comparar contra esos baremos; de lo contrario el resultado quedará invertido (mayor puntuación aparente = menor insatisfacción, un error clínico grave). Alternativa recomendada: reimprimir la hoja de respuesta con el orden 1=Nunca...6=Siempre antes de administrar, para evitar el paso de inversión manual.
Ítems invertidos	No hay ítems de contenido inverso dentro del cuestionario (los 34 ítems describen preocupación/insatisfacción en sentido

	directo); la única inversión necesaria es la de toda la escala de respuesta, según la advertencia anterior.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	34-204 (con la convención estándar 1=Nunca...6=Siempre, tras aplicar la inversión si se usa el protocolo local tal cual está impreso).
Puntos de corte	Raich (2000) sugiere un punto de corte orientativo de 105, aunque el propio artículo de adaptación aclara que no hay puntos de corte de consenso plenamente establecidos para clasificar patología. Medias de referencia del estudio de 1996: población universitaria general $M \approx 81,5-84,8$ (Cooper et al., 1987; Raich et al., 1996); subgrupo "preocupadas" $M \approx 109-110$; pacientes con anorexia/bulimia/bulimarexia $M \approx 127-145$.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (copia directa del PDF ya presente en el acervo del proyecto, Otros/output/pdf/BSQ_Scale.pdf; contenido verificado ítem por ítem contra el anexo del artículo original de 1996, coincide en las 34 preguntas). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Ficha generada a partir de fuente primaria verificable (texto completo del artículo de adaptación española de 1996 leído íntegramente); se detectó y documentó una discrepancia real de orden de la escala de respuesta mediante inspección visual de la página (no solo texto extraído). Requiere revisión humana antes de uso clínico, en especial confirmar la dirección de la escala antes de puntuar.
Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: Insatisfacción con la forma y figura corporal — preocupación por el peso, miedo a engordar, autodesvalorización por la apariencia física, deseo de perder peso y evitación de situaciones donde el cuerpo pueda ser observado por otros.

Finalidad

Evaluar la intensidad de la insatisfacción corporal en las últimas cuatro semanas; instrumento ampliamente usado en el cribado y seguimiento de trastornos de la conducta alimentaria y del trastorno de la imagen corporal.

Usos apropiados

Cribado e investigación de insatisfacción con la imagen corporal en muestras adultas (predominantemente femeninas, validación original).

Seguimiento de cambio terapéutico en tratamientos de trastornos de la conducta alimentaria o de imagen corporal (el estudio de validación reporta sensibilidad al cambio pre/post terapia cognitivo-conductual).

Complemento a otras medidas de conducta alimentaria dentro de una evaluación multimétodo (p. ej. EAT-26/40, si están presentes en este acervo).

Usos NO apropiados

Diagnóstico autónomo de un trastorno de la conducta alimentaria: el propio estudio de validación indica que no existen puntos de corte de consenso plenamente establecidos.

Uso en población masculina sin advertencia: la validación española se hizo explícitamente solo en mujeres; usar con hombres requiere cautela clínica y no cuenta con baremos propios en esta fuente.

Puntuar sin resolver primero la advertencia sobre la dirección de la escala de respuesta (ver ficha, campo 'Regla de puntuación').

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación y validación en población española (Raich et al., 1996, Universitat Autònoma de Barcelona), con datos también de pacientes diagnosticadas con trastornos alimentarios del Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona). No se localizó, en esta búsqueda, una adaptación con normas propias para Latinoamérica — no verificado; existen validaciones y estudios de uso del BSQ en México y Perú (ver referencias) pero no se confirmó si aportan baremos poblacionales propios.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Instrumento validado únicamente en mujeres; su uso en hombres no cuenta con baremos ni puntos de corte propios verificados en esta fuente.

No sustituye una entrevista clínica estructurada para trastornos de la conducta alimentaria ni el juicio clínico profesional.

Contiene ítems sobre conductas compensatorias (vómito, laxantes, ítems 26 y 32) que pueden requerir seguimiento clínico directo independientemente de la puntuación total; el

propio estudio de 1996 señala que estos dos ítems son los que menos correlacionan con el resto del instrumento en población general, por evaluar conductas más extremas.

Confirmar siempre la dirección de la escala de respuesta impresa antes de puntuar (ver advertencia inicial de esta ficha).

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El BSQ original (Cooper et al., 1987) y su adaptación española (Raich et al., 1996) están ampliamente reproducidos en la literatura científica internacional con fines de investigación y clínicos; el artículo de 1996 incluye el cuestionario íntegro en un anexo de acceso académico (Clínica y Salud, revista del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid). No se identificó editorial comercial que restrinja específicamente el uso académico/clínico no comercial de esta versión de 34 ítems (existen versiones abreviadas comerciales -BSQ-16, BSQ-8b- no cubiertas por esta ficha). Verificar condiciones de reproducción antes de cualquier uso comercial o redistribución masiva — no verificado con certeza absoluta.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Cooper, P. J., Taylor, M. J., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (1987). The development and validation of the Body Shape Questionnaire. *International Journal of Eating Disorders*, 6(4), 485-494.

Raich, R. M., Mora, M., Soler, A., Ávila, C., Clos, I., & Zapater, L. (1996). Adaptación de un instrumento de evaluación de la insatisfacción corporal. *Clínica y Salud*, 7(1), 51-66.
<https://journals.copmadrid.org/clysa/archivos/1996/vol1/arti4.htm> (texto completo con el anexo del cuestionario, leído íntegramente durante esta verificación).